

TEMA 5.6 • HEMATOLOGÍA

Anemia por Déficit de Vitamina B12 y Folatos

PERFIL EUNACOM 1.071.006
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Talasemias

Definición

Hemoglobinopatías genéticas por alteración en la producción de cadenas globina de la Hb → **Anemia: Generalidades** anemia hemolítica crónica.

- **Alfa-talasemia:** afecta cadenas alfa → presente **desde el nacimiento** (la Hb fetal también usa cadenas alfa)
- **Beta-talasemia:** afecta cadenas beta → presente desde los **3-6 meses** (recién se sustituye la Hb fetal por adulta)

Diagnóstico

- **Hemograma:** anemia microsítica, pero con diferencias clave respecto a la ferropenia:

TABLA 5.6.1: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS		
	TALASEMIA	FERROPENIA
Tamaño de glóbulos rojos	Isocitosis (RDW normal; todos pequeños e iguales)	Anisocitosis (RDW ↑; tamaños variables)
Número de GR	↑ (a veces > 5-6 millones/mm³)	Normal o ↓
Perfil de hierro	Normal o sobrecarga	Ferritina ↓

- **Diagnóstico definitivo:** electroforesis de hemoglobina o cromatografía (busca Hb A2 ↑ en beta-talasemia) + análisis genético

Tratamiento

TABLA 5.6.2: SEVERIDAD VS TRATAMIENTO	
SEVERIDAD	TRATAMIENTO
Leve (rasgo talasémico)	Solo observar
Moderada	Transfusiones periódicas
Grave	Transfusiones + quelantes de hierro (para evitar hemocromatosis secundaria)

EUNACOM CRITERIOS
Hemocromatosis secundaria es una complicación frecuente en talasemias transfusión-dependientes → hay que quelar el hierro.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Paciente con anemia microcítica, índice de dispersión eritrocitaria normal y recuento de glóbulos rojos de 6 millones/mm³. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Anemia por Déficit de Vitamina B12 y Folatos. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

- PUNTOS CLAVE DESTACADOS**
- Las talasemias son anemias microcíticas crónicas que se confunden con ferropénica
 - Diferencia clave 1: isocitosis en talasemia (IDE normal) vs anisocitosis en ferropénica (IDE aumentado)
 - Diferencia clave 2: glóbulos rojos aumentados en talasemia a pesar de la hemoglobina baja
 - Alfa talasemia: presente desde el nacimiento. Beta talasemia: desde los 6 meses
 - El diagnóstico se confirma con electroforesis de hemoglobina o análisis genéticos
 - El perfil de hierro puede ser normal o mostrar sobrecarga (hemocromatosis secundaria)
 - Tratamiento: observación en leves, transfusiones periódicas en graves, quelantes de hierro si hay sobrecarga

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ANEMIA POR DÉFICIT DE VITAMINA B12 Y FOLATOS)

PREGUNTA 1

Paciente con anemia microcítica, índice de dispersión eritrocitaria normal y recuento de glóbulos rojos de 6 millones/mm³. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Anemia ferropénica
- B)** Talasemia
- C)** Anemia sideroblástica
- D)** Anemia por enfermedades crónicas
- E)** Déficit de vitamina B12

PREGUNTA 2

¿A partir de qué edad se manifiesta la beta talasemia?

- A)** Desde el nacimiento
- B)** Desde los 3-6 meses
- C)** Desde los 2 años
- D)** Desde la adolescencia
- E)** In útero

PREGUNTA 3

¿Cuál es el examen confirmatorio para el diagnóstico de talasemia?

- A)** Perfil de hierro
- B)** Biopsia de médula ósea
- C)** Electroforesis de hemoglobina
- D)** Prueba de Coombs
- E)** Índice reticulocitario

RESUMEN: ANEMIA POR DÉFICIT DE VITAMINA B12 Y FOLATOS

Esta clase cubre las hemoglobinopatías, centrada en las talasemias y la anemia de células falciformes. Las talasemias son patologías genéticas con anemia crónica de severidad variable. La alfa talasemia se manifiesta desde el nacimiento y la beta talasemia desde los 6 meses de edad. Las talasemias se diferencian de la ferropénica por dos hallazgos clave: isocitosis (índice de dispersión eritrocitaria normal) versus anisocitosis en la ferropénica, y aumento del número de glóbulos rojos a pesar de la anemia. El diagnóstico se confirma con electroforesis de hemoglobina. Nota: El archivo de transcript correspondiente a la lección 06 contiene contenido sobre hemoglobinopatías (talasemias y anemia drepanocítica) que se superpone con la lección 07. El contenido de déficit de vitamina B12 y folatos no se encuentra disponible en el transcript proporcionado.